

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN

ANTARA

PT Pertamina (Persero), PT KPI, PT Patra Niaga, PT PIS

DENGAN

RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya

Nomor : 020/PNDAD0000/2022-S0

Nomor : 985.2 /U00000/2022-S0

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan ("Perjanjian") dibuat pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT Pertamina (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Ramdhan Lukiswara** selaku **Manager Health Services** berdasarkan Surat Keputusan SKMJ-01476/K20500/2020-S8 tanggal 29 September 2020

PT KPI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Diyon Indarto** selaku **Manager Health** berdasarkan Surat Keputusan SKMJ-00907/K20500/2021-S8 tanggal 20 Agustus 2021

PT Patra Niaga suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Wisma Tugu II Jalan HR. Rasuna Said, Kavling C7-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Sindu Agung Lesmana** selaku **Manager Health & Medical** berdasarkan Surat Keputusan SKMJ-01171/K20500/2021-S8 tanggal 01 September 2021

PT PIS suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan Yos Sudarso No. 32-34, Gedung Lama, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Teddi Setiawan** selaku **Manager Health** berdasarkan Surat Keputusan SKMJ-01655/K20520/2021-S8 tanggal 14 Juni 2021

dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta selatan 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh

karenanya dalam hal ini sah bertindak atas nama Badan Hukum tersebut diatas, yang selanjut disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa layanan kesehatan di wilayah Sulawesi dan sekitarnya untuk melayani Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai prinsip Managed Care sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan bersedia memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sepakat menunjuk **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** sepakat menerima penunjukkan **PIHAK PERTAMA**, untuk memberikan layanan kesehatan kepada Peserta sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan dan mengikat diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **ISTILAH DAN PENGERTIAN**

1. **Managed Care** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menerapkan manajemen pengendalian utilisasi dan biaya serta program jaga mutu yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
2. **Peserta** adalah pekerja **PIHAK PERTAMA** yang masih aktif bekerja dan keluarganya (istri/suami, anak) yang terdaftar secara resmi di **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
3. **Kartu Peserta (Medical Card)** adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pekerja **PIHAK PERTAMA** yang masih aktif bekerja dan keluarganya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
4. **Surat Jaminan** adalah surat jaminan, pengantar atau persetujuan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Peserta tidak membawa atau tidak memiliki Surat Rujukan.
5. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. **Sistem Rujukan pelayanan kesehatan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan
7. **Sistem Layanan Berjenjang** adalah layanan berjenjang yang rasional dan sesuai dengan kaidah-kaidah medis yaitu proses layanan dari PPK Tingkat Pertama ke PPK

Tingkat Lanjutan (setelah melalui proses pemeriksaan dan atau pengobatan di PPK Tingkat Pertama).

8. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter PPK Tingkat Pertama untuk pemeriksaan lebih lanjut di PPK Tingkat Lanjutan.
9. **Surat Jawaban Konsultasi** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** yang berbentuk resume medik pasien selama perawatan/ mendapat pelayanan kesehatan, dan hanya diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
10. **Standar Pelayanan Medis** adalah standar atau pedoman dalam praktek pelayanan medis **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan secara resmi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku, dimana standar pelayanan medis tersebut harus minimal sama dengan standar yang ditetapkan oleh kolegium profesi dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
11. **Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama** selanjutnya disebut **PPK Tingkat PERTAMA** adalah pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi Peserta berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Layanan Penunjang.
12. **Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Lanjutan** selanjutnya disebut **PPK Tingkat Lanjutan** adalah pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan spesialisik bagi Peserta berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap dan Layanan Penunjang.
13. **Rawat Jalan** adalah pelayanan kesehatan baik di PPK Tingkat Pertama maupun PPK Tingkat Lanjut yang tidak memerlukan rawat inap, dan terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Pertama/RJTP dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/RJTL.
14. **Rawat Jalan Tingkat Pertama/RJTP (Primary Health Care)** adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan tingkat dasar yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, bidan, klinik 24 jam, Rumah Sakit dengan atau tanpa obat selain Rawat Inap/tidak memerlukan Rawat Inap, termasuk pelayanan gawat darurat di unit gawat darurat (UGD).
15. **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/RJTL (Secondary Health Care)** adalah semua pemeliharaan kesehatan termasuk penunjang diagnostik, pembedahan sederhana, Rehabilitasi, serta tindakan medis lainnya yang diminta dan atau dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter ahli yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Surat Rujukan dari dokter di RJTP, termasuk One Day Surgery, pelayanan gawat darurat di unit gawat darurat (UGD) dan Emergency.
16. **Rawat Inap** adalah perawatan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit dimana penderita menginap sedikitnya 1 (satu) malam berdasarkan rujukan dari dokter yang melakukan Rawat Jalan.
17. **Emergency** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi pasien (dibuktikan dengan data resep obat dan atau bukti tindakan yang diberikan oleh dokter yang merawat).
18. **One Day Surgery (ODC)** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa tenaga anestesi di mana Peserta dapat langsung pulang, tanpa harus melaksanakan Rawat Inap (merupakan paket biaya tindakan yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, sewa kamar, dan lain-lain yang merupakan bagian dari tindakan tersebut).
19. **Obat atau Terapi** adalah semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dapat diberikan dengan diminum, disuntik, dioles, dihirup, atau diteteskan sesuai dengan Daftar Obat Essensial Nasional, yang diakui oleh pemerintah yang



berwenang dalam rangka penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan kecuali makanan, tidak termasuk obat-obatan yang masih bersifat percobaan atau hipotesa

20. **Layanan Penunjang** adalah layanan yang dilaksanakan di PPK Tingkat Pertama maupun PPK Tingkat Lanjutan untuk membantu tenaga medis dalam proses penegakan diagnosa suatu penyakit, yang meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, mikrobiologi, patologi anatomi, dll dan pemeriksaan penunjang lainnya.
21. **Rehabilitasi** adalah semua tindakan yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak keadaan sakit, nyeri, cacat dan atau halangan serta meningkatkan kemampuan pasien mencapai integrasi sosial.
22. **Tarif Paket** adalah besaran tarif layanan kesehatan dengan nominal yang sudah ditentukan berdasarkan paket suatu tindakan terapi
23. **Tenaga Medis** adalah tenaga profesional yang mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia, sehingga secara mandiri dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri. Yang digolongkan dalam kriteria ini adalah dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.
24. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang digolongkan dalam kriteria ini adalah perawat, bidan, analis kesehatan, fisioterapi dll.
25. **Keadaan Darurat** adalah setiap keadaan yang mengakibatkan suatu kondisi yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA** dan dapat membahayakan keselamatan jiwa, kerusakan bangunan/harta benda serta perlu segera ditanggulangi.
26. **Medical Emergency Respon Plan** adalah bagian integral dari sistem tanggap darurat yang bertujuan untuk mengurangi dampak penyakit mendadak dan cedera di tempat kerja melalui pertolongan pertama di tempat kerja, stabilisasi penderita, evakuasi medis dan penanganan penderita di rumah sakit terdekat/rujukan
27. **Proses Validasi dan Verifikasi** adalah proses validasi dan verifikasi penagihan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** atas layanan kesehatan atau pengobatan dan/atau tindakan medis yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
28. **Utilization Review (Telaah Utilisasi)** adalah instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK).
29. **Rawat Bersama** adalah pelayanan kesehatan terkoordinasi yang dilakukan oleh dua atau lebih dokter spesialis dan/atau subspesialis untuk kondisi medis tertentu yang terjadi pada satu waktu dan/atau berurutan pada satu individu pasien.
30. **ASO (Administration Service Only)** adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan proses validasi, penjaminan, preotorisasi, dan verifikasi terhadap pengobatan dan/atau tindakan medis terhadap Pekerja dan Keluarga **PIHAK PERTAMA**.
31. **FOPI** adalah Formularium Obat Pertamedika IHC
32. **Yayasan Kesehatan Pertamina (Yakes Pertamina)** adalah Pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai *payor* (pembayar) tagihan layanan kesehatan Peserta **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 MAKSUD PERJANJIAN

Maksud dari Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan prinsip Managed Care, yaitu layanan yang mengedepankan kendali mutu dan kendali biaya dengan prinsip lazim, layak dan wajar (*usual, customary & reasonable/U.C.R*), sesuai Standar Pelayanan Medis.

Pasal 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional kepada Peserta meliputi pelayanan PPK Tingkat Pertama, PPK Tingkat Lanjutan, Rawat Inap dan penanggulangan Keadaan Darurat / Medical Emergency Respon Plan berdasarkan prinsip Managed Care; prinsip lazim, layak dan wajar (*usual, customary & reasonable/U.C.R*); sesuai Standar Pelayanan Medis sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian ini dengan mengacu pada Lingkup pelayanan kesehatan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dan ketentuan **PIHAK PERTAMA** terkait ketentuan pelayanan kepada Peserta.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan :
 - a. Pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** secara profesional dan efisien yang diselenggarakan sesuai prinsip Managed Care; prinsip lazim, layak dan wajar (*usual, customary & reaonable/U.C.R*); sesuai Standar Pelayanan Medis dengan mengutamakan penggunaan obat-obatan sesuai Formularium Nasional secara konsisten dan berkelanjutan; Khusus PKS dengan Provider Pertamedika, secara otomatis **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan Formularium Pertamedika (FOPI)
 - b. Opini dari pihak lain (*second opinion*) setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Tanggapan dari **PIHAK KEDUA** atas saran/ usulan/keluhan yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/keluhan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Akses terhadap rekam medis Peserta (dapat melalui dokter yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**).
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - b. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - c. Menanggapi saran/usulan/keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/ keluhan dari **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan :

- a. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** yang telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
- b. Tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** atas saran/ usulan/ komplain/keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya komplain/keluhan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan kepada peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Managed Care; prinsip lazim, layak dan wajar (*usual, customary & reasonable/U.C.R*) serta Standar Pelayanan Medis
- b. Bertanggung jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis Peserta yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendukung dan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan *Utilization Review*.
- d. Menanggapi saran/usulan/komplain/keluhan yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya saran/usulan/keluhan dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memberikan akses rekam medis Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PIHAK KEDUA** sanggup membuat dan menyediakan kelengkapan administrasi dan resume medis meliputi :
 - i. Membuat resume medis Peserta yang telah mendapat pelayanan medis dari Dokter yang merawat dan disertakan kepada pasien pada saat pasien selesai menerima pelayanan medis.
 - ii. Membuat surat keterangan sebab kematian Peserta yang meninggal dunia sesuai formulir baku, yang diisi oleh dokter yang memberikan layanan/merawat/menangani secara lengkap dan benar termasuk menuliskan keterangan sebab kematian.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjalin kerjasama dengan pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan validasi dan verifikasi tagihan terkait layanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta berdasarkan ketentuan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini dan Peserta dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pelayanan kesehatan tersebut.
2. Kecuali untuk hal yang sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini, Tarif pelayanan kesehatan yang berlaku adalah tarif yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 tentang Tarif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Tarif untuk biaya-biaya jasa atau tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Medis, konsultasi dokter konsulen via telepon dan lain-lain yang tidak lazim berlaku atau yang menjadi suatu tarif numeratif honor tenaga profesional tidak ditanggung **PIHAK PERTAMA** dan menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki perubahan tarif atau penambahan tarif pelayanan baru, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan pemberlakuan tarif untuk layanan baru tersebut dapat digunakan bila telah disepakati **PARA PIHAK**.
5. Apabila tidak ada tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah usulan tarif tersebut diterima **PIHAK** lainnya maka tarif baru tersebut dianggap disetujui dan berlaku terhitung sejak batas waktu terlampaui.
6. Apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** terhadap usulan perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, maka tetap diberlakukan tarif lama dan tarif pelayanan baru tersebut tidak dapat diberlakukan.
7. Untuk kasus-kasus tertentu, **PIHAK KEDUA** memberlakukan Tarif Paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENANGANAN KEADAAN DARURAT / MEDICAL EMERGENCY RESPON PLAN

1. **PIHAK KEDUA** menerima informasi Keadaan Darurat dari **PIHAK PERTAMA** melalui *Contact Person (CP)* masing-masing **PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menyediakan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, ambulans, sarana, peralatan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan keadaan atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, ambulans, sarana, peralatan dan perlengkapan lainnya dapat menuju lokasi kejadian Keadaan Darurat sesuai informasi atau permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pelaporan atas penanganan Keadaan Darurat tersebut sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Semua biaya yang timbul akibat penanganan keadaan darurat tersebut akan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Dokumen penagihan untuk Peserta **PIHAK PERTAMA** dikirimkan ke Pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu PT Administrasi Medika yang bertindak sebagai perusahaan penyedia ASO (*Administrative Service Only*) untuk dilakukan proses validasi dan verifikasi.
2. Penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan nomor Perjanjian dan ditujukan sesuai alamat korespondensi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan populasi masing-masing entitas.

- b. Berita Acara Tagihan atas nama **PIHAK PERTAMA** (sesuai entitas asal pasien)
 - c. Rekap pengajuan penagihan dalam rangkap 2 (dua)
 - d. Perincian biaya per Peserta dengan melampirkan surat rujukan untuk pelayanan tingkat lanjut dan slip hasil validasi dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**
 - e. Kuitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai secukupnya (1 lembar asli kuitansi, dan 1 lembar copy kuitansi) yang ditujukan ke masing-masing entitas asal pasien
 - f. Kuitansi layanan dokter spesialis harus disertai *resume* medis
 - g. Faktur pajak untuk layanan obat Rawat Jalan
 - h. Kuitansi pemeriksaan laboratorium/penunjang harus disertai dengan Copy surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan tersebut dan Copy hasil pemeriksaan tersebut
 - i. Untuk pasien rawat inap harus disertai *resume* medis
3. Penagihan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah selesai mendapat layanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 4. Apabila dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini belum lengkap, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan kembali dokumen penagihan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan dokumen tersebut.
 5. Tagihan harus diterima **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya layanan kesehatan yang diperlukan Peserta oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan melebihi 60 (enam puluh) hari kalender maka tagihan tersebut tidak akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menagihkan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**.
 6. Pembayaran oleh **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu **Yakes PERTAMINA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
 7. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu **Yakes Pertamina** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
 8. Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 1. Nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
Bank : Bank BNI Cabang Mayestik Jakarta Selatan
No. Rek : 6336336628
 2. Nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
Bank : Bank BRI Cabang KC Tamalanrea
No. Rek : 403.01.001457.30.7

3. Nama : PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
Bank : Bank Mandiri KCP Makassar Daya
No. Rek : 152.0031524651

9. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** pembayaran tagihan yang telah dilakukan.

Pasal 8 POTONGAN/DISKON TAGIHAN

PIHAK KEDUA akan memberikan potongan 5% (lima persen) dari besarnya nilai nominal tagihan layanan kesehatan sesuai ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal Perjanjian ini jangka waktunya hendak diperpanjang, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 10 PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 SANKSI

1. Tanpa mengurangi hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi/melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketentuan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk (i) menunda pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini dan/atau (ii) memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam *black list* dari daftar rekanan **PIHAK PERTAMA**.
2. Sanksi sebagaimana tersebut diatas berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan pemberitahuan tertulis dan **PIHAK KEDUA** tetap tidak memenuhi/melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **PEMBERITAHUAN**

1. Korespondensi terkait Perjanjian ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui kurir, surat tercatat atau faksimili ke alamat yang disebut pada Perjanjian.
2. Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal pengesahan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili.
3. Jika terjadi perubahan alamat, Pihak yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
4. Alamat korespondensi masing-masing Pihak terkait Perjanjian ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA Patra Niaga – Regional Sulawesi

PIHAK KEDUA : RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya

Pasal 13 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Kecuali terkait dengan kewajiban pembayaran, suatu Pihak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari Pihak tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar : a) kerusakan massal, perang saudara, pemberotakan, perebutan kekuasaan, perang dengan Negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu Pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar berlangsung dan upaya-



upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini diatas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini diatas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari Pihak yang diberitahu, maka Pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka Pihak yang menyatakan Keadaan kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
9. Jika Pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh Pihak yang diberitahu, maka Pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat diminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadi Keadaan Kahar tersebut diakui oleh Pihak yang diberitahu, maka Para Pihak akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 14 **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa:

- a. **Perjanjian** ini ditandatangani oleh wakil **PIHAK KEDUA** yang berwenang;
- b. **PIHAK KEDUA** cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan Perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
- d. Semua informasi yang telah atau akan diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah lengkap, benar dan sah; dan
- e. **PIHAK KEDUA** telah mengetahui dan memahami ketentuan Perjanjian serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 15 **ETIKA BISNIS**

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

Pasal 16 KERAHASIAAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil dari pekerjaan merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. **PIHAK KEDUA**, termasuk personil **PIHAK KEDUA**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Pengungkapan **Informasi Rahasia** kepada personil **PIHAK KEDUA**, para pengurus **PIHAK PERTAMA**, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PIHAK KEDUA** yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua **Informasi Rahasia**, termasuk mewajibkan personil **PIHAK KEDUA** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
5. Ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KEDUA** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
6. Jika **PIHAK PERTAMA** terikat dalam suatu Perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani suatu Perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK PERTAMA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK PERTAMA** dengan pemilik data/informasi tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian berakhir.
8. Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.
9. Jika berdasarkan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak **Informasi Rahasia** tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

Pasal 17

AUDIT

1. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan Perjanjian Ini dengan benar dan sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Selama masa yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini di atas, **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan **PIHAK KEDUA**, dengan biayanya sendiri, wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan.
3. Apabila berdasarkan audit yang disebut dalam ayat 2 Pasal ini di atas ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menagih dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Pasal 18

PEMUTUSAN PERJANJIAN LEBIH AWAL

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) **PIHAK KEDUA** melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian ini putus jika, menurut pandangan **PIHAK PERTAMA** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang diberikan **PIHAK PERTAMA**; atau b) telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan yang berlaku; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau d) **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan **PIHAK PERTAMA** atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PIHAK PERTAMA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
4. Salah satu **PIHAK** dapat memutuskan **PERJANJIAN** apabila terjadi Keadaan Kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kalender.
5. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal putusnya Perjanjian.

6. Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya Perjanjian sebagaimana diatur di atas.

Pasal 19
PENGALIHAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah.
2. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase **BANI** dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.
3. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
4. **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 21
LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum bagi **PARA PIHAK**.
2. Apabila terdapat perbedaan antara isi dan penafsiran diantara ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** yang akan menentukan ketentuan mana yang akan berlaku.

Pasal 22
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia
2. Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh wakil **PIHAK PERTAMA** yang berwenang. Meskipun demikian, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** secara lisan dan **PIHAK KEDUA** harus tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi itu harus kemudian dikonfirmasi secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari **PIHAK KEDUA** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu

- maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari **PIHAK KEDUA**, maka instruksi lisan dari **PIHAK PERTAMA** tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.
3. Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam Perjanjian adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran Perjanjian ini.
 4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini.
 5. Tidak ada hak apapun dari satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK** tersebut. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 6. Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau Perjanjian ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari Perjanjian ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidakberlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.
 7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** maupun penggantinya.

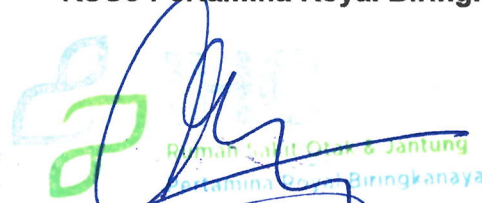
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh **PARA PIHAK** dan aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan **KEDUA**nya dibubuhi meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Pertamina (Persero)



dr. Ramdhan Lukiswara
PT Kilang Pertamina Internasional

PIHAK KEDUA
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur



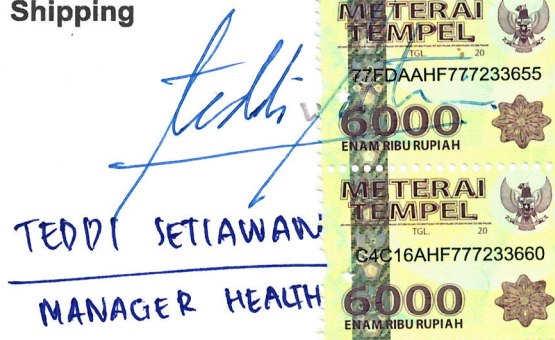
PT Pertamina Patra Niaga



*Manajemen Health & Medicine
Gedung Agung Pertamina*

PT Pertamina International Shipping

M.



TEDDI SETIAWAN
MANAGER HEALTH

Lampiran 1
LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- A. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) I** memberikan pelayanan kesehatan primer termasuk gigi umum kepada Peserta meliputi:
- a. Konsultasi dan pemeriksaan fisik
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnosis atas indikasi medis
 - c. Tindakan medis
- B. PPK Tingkat Lanjutan** memberikan pelayanan kesehatan sekunder, yaitu layanan sesuai kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis kepada Peserta meliputi:
- a. Konsultasi dan pemeriksaan dokter
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnosis atas indikasi medis
 - c. Tindakan medis (termasuk tindakan dokter dan paramedis)
 - d. Layanan Farmasi
 - e. Layanan rawat jalan dan hemodialisa
 - f. Layanan fisioterapi dan rehabilitasi medis
 - g. Layanan tindakan *One Day Care*
 - h. Layanan Gawat Darurat
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Berkala (MCU)
- C. RAWAT INAP** untuk Peserta meliputi:
- a. Konsultasi dan pemeriksaan dokter
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnosis atas indikasi medis
 - c. Tindakan medis (termasuk tindakan dokter dan paramedis)
 - d. Layanan Farmasi
 - e. Layanan *Intensive Care* atas indikasi medis
 - f. Kamar perawatan (*bundling*, termasuk diet/makan pasien)
- D. KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)**, meliputi:
- a. Konsultasi dan pemeriksaan fisik serta pelayanan promotif lainnya (pap smear, senam hamil, klinik laktasi)
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnosis atas indikasi medis
 - c. *Antenatal Care* (ANC) dan Persalinan
 - d. Tindakan medis sesuai indikasi
 - e. Persalinan bagi pekerja wanita atau istri pekerja
 - f. Layanan Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai standar kontrasepsi Nasional
 - g. Program Imunisasi sesuai dengan Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2011 sampai dengan usia 5 (lima) tahun dan booster sampai dengan usia 7 tahun. Imunisasi yang diberikan meliputi :
 - Imunisasi Dasar: BCG (untuk Tuberkulosis/TBC), DPT (untuk Dipteri, Pertusis dan Tetanus) Polio, Tetanus, Campak, dan Hepatitis B.
 - Imunisasi Tambahan : MMR (untuk Campak, Gondongan dan Rubella), HIB (untuk *Hemophilus Influenza*), Influenza, Hepatitis A, Varicella (untuk Cacar Air), IPD (untuk *Pneumokokus*), Tifoid, PCV, dan Rotavirus
- E. PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIS**, meliputi:
- a. Kedaruratan sistem pernafasan dan pendengaran
 - Mimisan
 - Sumbatan jalan nafas
 - Ketulian akut (*sudden deafness*)

- Batuk darah
 - Status asmatikus
 - Cedera dada (*trauma thoraks*)
 - Keluhan lain: sesak nafas, asma, dan ada benda asing
- b. Kedaruratan sistem jantung dan pembuluh darah:
- Syok
 - *Dengue shock syndrome*
 - Payah jantung akut
 - Krisis hipertensi
 - Infark Jantung
 - Cedera vaskuler (edema, nyeri yang bertambah)
 - Keluhan lain : nyeri dada, pusing kepala hebat, vertigo, migren, panas tinggi
- c. Kedaruratan Sistem Syaraf Pusat :
- Koma
 - Kejang
 - Gangguan Peredaran Darah (Stroke)
 - Cedera/trauma sistem syaraf pusat
 - Keluhan lain: cedera kepala, leher dan tulang belakang
- d. Kedaruratan Sistem Saluran Cerna
- Muntah darah
 - Berak darah
 - Gastroenteritis dehidrasi
 - Akut abdomen
 - Cedera perut
 - Keluhan lain: nyeri perut hebat, tidak bisa buang air besar dan flatus
- e. Kedaruratan Sistem Saluran Kemih
- Payah / gagal ginjal akut
 - Retensi urin
 - Cedera saluran kemih
 - Kolik renal dan ureter
 - Torsio testis
 - Keluhan lain: nyeri perut dan pinggang hebat, tidak bisa kencing, bengkak seluruh tubuh, dan kencing darah
- f. Kedaruratan Sistem Muskuloskeletal
- Patah tulang
 - Cedera anggota badan
 - Cedera sendi/dislokasi
 - Cedera tulang belakang
 - Sindroma kompartemen
- g. Kedaruratan Mata
- Glaukoma akut
 - Ulkus kornea
 - Uveitis anterior
 - Cedera mata
 - Penyumbatan pembuluh darah nadi/balik centralis retinae
 - Retinal detachment/ablasio retina
 - Keluhan lain: nyeri mata, kelopak mata sulit membuka, luka mata, penglihatan gelap mendadak

h. Kedaruratan Obstetri dan Ginekologi

- Keguguran
- Perdarahan sebelum melahirkan
- Perdarahan setelah melahirkan
- Kehamilan ektopik terganggu
- Keracunan kehamilan (eklamsia)
- Torsio adneksa
- Distosia (partus macet)
- Cedera kehamilan
- Gangguan kehamilan yang lain
- Keluhan lain: kejang, nyeri kepala hebat pada kehamilan tua, nyeri perut hebat pada saat hamil

i. Kedaruratan Bayi Baru Lahir (neonatus)

- Asfiksia neonatorum
- Sindroma gangguan pernapasan idiopatik
- Kuning (ikterus)
- Kejang
- Kelainan bawaan
- Trauma lahir
- Demam tinggi
- Dehidrasi

j. Kedaruratan Psikiatrik

- Reaksi histeris
- Psikosa akut
- Gaduh gelisah

k. Keracunan dan alergi

- Keracunan
- Gigitan dan sengatan binatang

l. Kedaruratan akibat Penyebab Lain

- Luka bakar
- Syok listrik
- Trauma dingin/panas
- Tenggelam
- Melahirkan
- Demam tinggi
- Perdarahan oleh sebab apapun

F. Perawatan meratakan gigi (ortodonsi) dan gigi palsu (prosthodonti) bagi pekerja, istri/suami, anak diberikan atas indikasi medis dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA

G. Infertilitas dan Bayi Tabung, diberikan atas indikasi medis dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA

H. PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG

- Layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur rujukan berjenjang, kecuali keadaan gawat darurat medis;
- Pengobatan dan perawatan penyakit akibat penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol
- Penggunaan logam mulia dan protesa tanam (*implant prothesis*) - untuk gigi

- iv. Pengobatan dan tindakan operasi plastik berindikasi kosmetika
- v. Pengobatan tradisional dan alternatif
- vi. Alat kesehatan, meliputi: alat kesehatan diagnostik, alat kesehatan ambulator (termasuk namun tidak terbatas pada kruk, kursi roda, stocking varises, tabung oksigen)
- vii. Biaya pelayanan kesehatan anak ke-4 dan seterusnya, yang bukan merupakan anak kembar.
- viii. Semua tindakan, perawatan dan pelayanan di luar wilayah Indonesia yang belum mendapatkan persetujuan Medical Board **PIHAK PERTAMA**.
- ix. Khitan (circumsisi) tanpa indikasi medis
- x. Home Care/Home Nursing dapat dijamin hanya untuk kasus-kasus tertentu sesuai pertimbangan Medical Board **PIHAK PERTAMA**
- xi. Biaya telepon, facsimile dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan.
- xii. Biaya laundry, biaya makan/catering pendamping pasien, atau biaya lain yang tidak digunakan pasien rawat inap
- xiii. Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada percobaan bunuh diri, dan pelanggaran hukum lainnya.
- xiv. Gangguan/cedera akibat olahraga tertentu yang membahayakan seperti: panjat gunung/tebing, hang gliding, balap mobil/motor, diving, parasut, tinju, akrobatik, scuba diving dll.
- xv. Semua perawatan dan pengobatan untuk kosmetik/kecantikan seperti: sabun, pasta gigi, obat jerawat/acne, dan tindakan operasi plastik (Cosmetic Surgery) seperti: keloid, dan akibatnya.
- xvi. Pelayanan kesehatan bagi pekerja yang melaksanakan ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah ke luar negeri
- xvii. Pelayanan kesehatan bagi anak pekerja yang melaksanakan pendidikan di Luar Negeri
- xviii. Penggunaan hak atas rawat inap atau perpanjangan periode rawat inap tanpa indikasi medis dan/atau atas permintaan Peserta sendiri.

I. PENGATURAN PENGGUNAAN OBAT

a. Peresepan obat diatur dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

- Pilihan Pertama : Obat Generik sesuai Formularium Nasional.
 - Pilihan Kedua : Obat dengan jenis yang sama, produksi pabrik obat PMDN dan sesuai Formularium RS.
 - Pilihan Ketiga : Obat dengan jenis yang sama, produksi obat PMA dan sesuai Formularium RS
- b. Maksimum 3 (tiga) item per lembar resep atau sesuai indikasi medis.
 - c. Untuk kasus akut, obat diberikan maksimal 5 (lima) hari.
 - d. Untuk penyakit kronik, obat-obatan maksimal dapat diberikan untuk 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan iterisasi maksimal 2 (dua) kali.

J. PENJAMINAN LAIN-LAIN

Berikut ini merupakan hal-hal yang masih ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Peserta, yaitu :

- a. Alat kesehatan berupa collar neck dan lumbal korset, diberikan satu kali.
- b. Implant alat kesehatan orthopedi yang diberikan atas indikasi medis.
- c. Operasi kosmetik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis tubuh yang rusak.

Untuk kasus-kasus lain yang tidak termasuk dalam layanan kesehatan yang tidak ditanggung dilakukan melalui preotorisasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**.

Lampiran 2 PROSEDUR LAYANAN KESEHATAN

A. Prosedur Layanan Kesehatan Rawat Jalan

1. Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, sebelum dilakukan pelayanan, pemeriksaan dan/atau pengobatan kesehatan kepada Peserta, **PIHAK KEDUA** harus:
 - a. Meminta Peserta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan Kartu Peserta (*Medical Card*)/Surat Jaminan, yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA**, atas nama Peserta yang bersangkutan yang masih berlaku, guna proses validasi dan verifikasi Peserta sehingga pemeriksaan dan/atau pengobatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**. Dalam keadaan proses validasi dan verifikasi Peserta tidak bisa dilakukan/didapatkan secara *online (off line)*, maka **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** (khususnya jika dalam kondisi diluar jam kerja/ hari libur dengan menyebutkan identitas Peserta tersebut); atau
 - b. Dalam hal Emergency, melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kartu Peserta atau kartu pengenalan pekerja yang dimiliki Peserta atau identitas lainnya untuk memastikan bahwa yang akan dilayani adalah Peserta **PIHAK PERTAMA**. Apabila pasien adalah Peserta, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat Jaminan dalam waktu 2 x 24 jam atau pada hari kerja berikutnya jika jatuh pada hari libur.
2. Apabila hasil validasi dan verifikasi Peserta menunjukkan Peserta memenuhi ketentuan huruf a dan b ayat 1 Pasal ini dan Peserta mempunyai hak pelayanan kesehatan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan layanan kesehatan yang diperlukan kepada Peserta. Apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan ayat 1 Pasal ini, maka Peserta tidak berhak mendapat layanan kesehatan **PIHAK KEDUA** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Perjanjian ini dan seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya terkait layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diberlakukan sebagai pasien umum.
3. Untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib membawa Surat Rujukan atau Surat Jaminan kecuali untuk (i) anak sampai usia 11 tahun yang secara langsung berhak mendapatkan layanan dokter spesialis dan (ii) ibu hamil untuk kunjungan kedua dan seterusnya serta kunjungan ke dokter spesialis mata.
 - b. **PIHAK KEDUA** meminta Peserta **PIHAK PERTAMA** untuk menunjukkan Kartu berobat yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA**, Kartu Identitas lain atas nama Peserta yang bersangkutan yang masih berlaku, dan surat rujukan dari dokter PPK Tingkat Pertama guna proses validasi dan verifikasi Peserta
 - c. Apabila hasil validasi dan verifikasi Peserta menunjukkan Peserta memenuhi ketentuan, maka **PIHAK KEDUA** memberikan layanan kesehatan yang diperlukan kepada Peserta. Apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan, maka Peserta tidak berhak mendapat layanan kesehatan **PIHAK KEDUA** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya terkait layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diberlakukan sebagai pasien umum.
 - d. Peserta berhak memilih nama Dokter Spesialis yang dikehendaki sesuai dengan daftar nama dokter spesialis yang tersedia. Apabila dokter spesialis yang dituju ternyata tidak praktik maka dapat dialihkan ke dokter spesialis lain dengan bidang yang sama.

- e. Dokter spesialis **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Jawaban Konsultasi dengan jelas termasuk rencana pemeriksaan / tindakan medis lanjutan dan mengembalikan Peserta kepada pihak/dokter yang melakukan layanan Rawat Jalan Tingkat Pertama sebelumnya (yang mengirim).
 - f. Untuk pasien dengan penyakit kronis, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan atau tindakan yang diminta, **PIHAK KEDUA** mengembalikan Peserta kepada dokter yang mengirim.
 - g. Dokter Spesialis yang merupakan rujukan utama dapat memberikan konsul lebih lanjut untuk kasus yang multidiagnosis sesuai dengan kondisi pasien dan berkorelasi dengan penyakit utama yang ditanganinya dengan maksimal konsul 1 (satu) kali ke dokter Spesialis lain tiap 1 (satu) episode konsultasi.
 - h. Surat rujukan berlaku hanya untuk 1 episode layanan yang sama dan untuk 1 jenis spesialisasi, dengan masa berlaku surat rujukan 30 hari sejak diterbitkannya surat rujukan tersebut.
 - i. Untuk Fisioterapi, surat rujukan berlaku untuk 1 paket terapi sebanyak 6 kali. Adapun penentuan apakah Peserta dapat menjalankan fisioterapi tambahan berdasarkan atas penilaian dokter PPK I **PIHAK PERTAMA**.
 - j. Untuk Radioterapi, surat rujukan berlaku selama periode radioterapi sebanyak 20-25 kali (tidak termasuk booster / tambahan)
 - k. Untuk Haemodialisa reguler, satu kali penerbitan surat rujukan berlaku untuk layanan hemodialisa selama 3 bulan.
4. Batasan-batasan layanan kesehatan untuk peserta **PIHAK PERTAMA** untuk fasilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjutan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Medis yang diberikan adalah layanan Emergency, Rawat Jalan Tingkat Lanjut, dan Layanan Penunjang.
 - b. Pemberian obat secara rasional berdasarkan indikasi penyakitnya dengan mengutamakan pemberian obat sesuai Formularium Nasional
 - c. Pemeriksaan penunjang medis dan obat-obatan dengan biaya lebih besar dari Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per item obat (R/), agar meminta ijin terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dengan mengirimkan format persetujuan tindakan disertai besaran biaya ke alamat **PIHAK PERTAMA** atau alamat lain yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali untuk pelayanan gawat darurat di unit gawat darurat (UGD) atau Emergency, yang mana **PIHAK KEDUA** dapat terlebih dahulu melakukan layanan/tindakan medis ataupun pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk *life saving*.
 - d. Untuk penyakit kronis (hypertensi, TBC, Diabetes Mellitus dan penyakit lain yang memerlukan pemberian obat secara teratur dan berkelanjutan) pemberian obat maksimum untuk 1 (satu) bulan dan apabila sedang mendapat layanan dari PPK Tingkat Lanjutan, agar dikembalikan ke PPK Tingkat Pertama yang mengirim untuk perawatan selanjutnya.

B. Prosedur Layanan Kesehatan Rawat Inap

1. **PIHAK KEDUA** hanya menerima pasien dari **PIHAK PERTAMA** yang dilengkapi dengan Surat Rujukan atau Surat Jaminan, kecuali apabila sakit pada hari libur atau karena kecelakaan atau keadaan Emergency yang hanya dapat dilakukan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam berikutnya dengan menunjukkan Kartu Peserta, kartu identitas pekerja atau bukti/informasi identitas lainnya yang berfoto. Apabila memenuhi pengecualian tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk validasi dan verifikasi Peserta secara sistem *on line*, apabila validasi dan verifikasi Peserta tidak bisa

dilakukan/didapatkan secara *on line* **PIHAK KEDUA** dapat melakukan konfirmasi secara off line kepada **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** belum mendapat kepastian mengenai Peserta meskipun telah melakukan upaya untuk melakukan validasi dan verifikasi kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta

2. Apabila dalam tenggang waktu 2 x 24 jam yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini jatuh pada hari libur, kelengkapan Surat Rujukan atau Surat Jaminan harus disampaikan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
3. Peserta **PIHAK PERTAMA** akan ditempatkan pada kelas perawatan yang sesuai dengan hak kelas yang tercantum dalam Surat Jaminan, Kartu Peserta, hasil validasi dan verifikasi dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**. Secara umum penempatan kelas perawatan diatur sebagai berikut:

JABATAN/ PRL	FASILITAS PERAWATAN RS TYPE A/B	FASILITAS PERAWATAN RS TYPE C	FASILITAS PERAWATAN RS TYPE D
Direksi (diatur terpisah dalam SK)	Kelas tertinggi	Kelas tertinggi	Kelas tertinggi
<i>Lead Executive</i> (PRL 25 – 26)	Satu tempat tidur, tempat tidur pendamping, kamar tamu, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Senior Executive</i> .	Kelas tertinggi	Kelas tertinggi
<i>Senior Executive</i> (PRL 22 – 24)	Satu tempat tidur, tempat tidur pendamping, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Executive</i> .	Satu tempat tidur, tempat tidur pendamping, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Executive</i> .	Kelas tertinggi
<i>Executive</i> (PRL 19 – 21)	Satu tempat tidur, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Senior Staff</i> .	Satu tempat tidur, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Senior Staff</i> .	Kelas tertinggi
<i>Senior Staff</i> (PRL 16-18)	Satu tempat tidur kelas terendah, AC	Satu tempat tidur, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Staff</i> .	Satu tempat tidur, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Staff</i> .
<i>Staff</i> (PRL 12 – 15)	Dua tempat tidur, AC	Satu tempat tidur kelas terendah, AC	Satu tempat tidur, AC atau satu kelas diatas kelas rawat <i>Senior Staff</i>
<i>Junior Staff</i> (PRL 8 – 11)	Lebih dari dua tempat tidur, AC.	Dua tempat tidur, AC.	Satu tempat tidur kelas terendah, AC

4. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak peserta pada saat itu tidak tersedia atau penuh, maka sambil menunggu tersedianya kelas perawatan yang sesuai dengan haknya dapat menempati kelas maksimal dua tingkat lebih tinggi selama 2 x 24 jam dengan tarif sesuai yang ditempati. Jika setelah 2 x 24 jam dari waktu yang ditentukan pasien tetap menempati kelas kamar yang satu tingkat lebih tinggi, maka tarif yang ditagihkan ke **PIHAK PERTAMA** adalah yang sesuai dengan haknya.
5. Bila pasien meminta sendiri dirawat di kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka seluruh selisih biaya akibat kenaikan kelas tersebut dibebankan kepada Peserta dan dibayarkan langsung saat Peserta sebelum keluar dari rumah sakit.
6. Batasan-batasan layanan kesehatan untuk peserta **PIHAK PERTAMA** untuk fasilitas Rawat Inap sebagai berikut :
 - a. Pemberian obat secara rasional dan sesuai indikasi medis mengacu pada Standar Pelayanan Medis **PIHAK KEDUA**
 - b. Obat-obatan dengan biaya lebih besar dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per R/, pemeriksaan penunjang medis dengan biaya lebih besar dari **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan tindakan operasi dengan biaya lebih besar dari **Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)** agar meminta ijin terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan estimasi biaya yang akan timbul tersebut ke alamat sebagaimana tersebut pada Pasal 12 atau alamat lain yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
7. Untuk Pelayanan Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dokter spesialis yang merawat dapat merujuk ke dokter spesialis yang lain sesuai dengan indikasi penyakit pasien yang dirawat inap.
 - b. Apabila indikasi penyakit pasien mengancam jiwa Peserta, maka pada pasien tersebut dapat disetujui perawatan Konsultasi "Rawat Bersama".
 - c. Peserta dapat dilayani oleh dokter spesialis dengan konsultasi dengan dokter spesialis yang lain tetapi bukan merupakan "Rawat Bersama".
 - d. Pada kondisi tertentu dipandang perlu, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta penjelasan secara medis/ *medical record* kepada **PIHAK KEDUA**.
8. Obat dan alat medis yang dipakai oleh Farmasi **PIHAK KEDUA** diutamakan sesuai dengan Formularium Nasional
9. Apabila Peserta **PIHAK PERTAMA** memerlukan Rawat Inap, akan tetapi tempat tidur di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam keadaan penuh, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirim/merujuk ke Rumah Sakit lain yang merupakan jejaring **PIHAK PERTAMA** di wilayah Jabodetabek yang memiliki Standar Pelayanan Kesehatan yang sama dengan **PIHAK KEDUA** dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**
10. Apabila dianggap perlu dan dengan pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan pasien, dokter yang merawat dapat merujuk Peserta **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit lain di wilayah **Sulawesi** dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**
11. Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan akan dibayarkan melalui **PIHAK KEDUA** kepada Rumah Sakit tersebut

C. Prosedur Layanan *Emergency* diatur sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu melakukan penanganan sesuai indikasi medis Peserta.
- b. Perihal validasi dan verifikasi kepesertaan, **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal 1x24 jam, dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan jawaban konfirmasi maksimal 1x24 jam.
- c. Apabila hasil validasi dan verifikasi menyatakan bahwa pasien merupakan Peserta **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menjamin biaya layanan kesehatan yang timbul pada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini. Apabila hasil validasi dan verifikasi menyatakan bahwa pasien bukan Peserta **PIHAK PERTAMA**, maka seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya terkait layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pasien menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diberlakukan sebagai pasien umum.